

Disfunción sexual femenina

WARWIKI

Información para el paciente · Problemas comunes y a menudo tratables con el sexo

La disfunción sexual femenina son problemas continuos con el **deseo, la excitación, el orgasmo o el dolor durante el sexo** que le molestan. Es común a cualquier edad, por lo general tiene más de una causa — física, hormonal y emocional — y muy a menudo se puede tratar. Es un tema médico que vale la pena mencionar; su equipo puede ayudarle sin juzgarle.

Acerca de esta afección

Los problemas suelen estar en una o más áreas:

- **Deseo** — poco interés en el sexo
- **Excitación** — dificultad para excitarse o mantenerse excitada; sequedad
- **Orgasmo** — dificultad para llegar al clímax
- **Dolor** — molestia durante o después del sexo (dispareunia)

Qué la causa

A menudo es una mezcla de factores:

- **Menopausia / estrógeno bajo** — sequedad y adelgazamiento vaginal (SGM)
- Un **suelo pélvico tenso o doloroso**, prolapso o preocupación por los escapes
- Afecciones médicas, cirugías previas y algunos **medicamentos** (por ejemplo, ciertos antidepresivos)
- Estrés, estado de ánimo, sueño y factores de pareja

APRENDA LOS TÉRMINOS

Libido

Deseo o interés sexual.

Excitación

La respuesta física del cuerpo, incluida la lubricación.

Dispareunia

Dolor durante o después de la actividad sexual.

SGM

Síndrome genitourinario de la menopausia — sequedad y adelgazamiento por el estrógeno bajo.

Estrógeno vaginal

Un tratamiento local de dosis baja para la sequedad y la molestia.

Fisioterapia del suelo pélvico

Terapia para el dolor por músculos pélvicos tensos.

Lubricante / hidratante

Productos no hormonales que alivian la sequedad y la fricción.

¿ESTÁ "TODO EN MI CABEZA"? No. Hay causas físicas reales y tratables — sequedad, un suelo pélvico tenso, prolapso, efectos de los medicamentos — junto con factores emocionales y de pareja que también importan. Una buena evaluación las analiza todas, y la mayoría de las personas logra una mejoría significativa.

Cómo se evalúa

- Una conversación atenta y confidencial sobre sus preocupaciones y su historia
- Un examen para encontrar causas físicas tratables (sequedad, tensión del suelo pélvico, prolapso)
- Una revisión de sus medicamentos y su salud general

Cómo se trata

- 1 **Aliviar la sequedad y el dolor** — lubricantes e hidratantes, y **estrógeno vaginal** para la sequedad relacionada con la menopausia.
- 2 **Fisioterapia del suelo pélvico** para el dolor o la tensión muscular.
- 3 **Tratar los factores que contribuyen** — prolapso, escapes o medicamentos que reducen el deseo.
- 4 **Asesoramiento / terapia sexual** y atención al estado de ánimo, el estrés, el sueño y la relación de pareja.

Pasos útiles

- Use un buen **lubricante** para la actividad y un **hidratante** con regularidad para la sequedad.
- Una comunicación abierta con su pareja reduce la presión y el dolor.
- Dé tiempo a los tratamientos; combinar enfoques suele funcionar mejor.

Avise a su equipo sobre:

- Dolor nuevo, un **bulto o masa**, o sangrado inusual
- Sangrado después del sexo o después de la menopausia
- Cualquier preocupación por su seguridad en la relación

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Los problemas sexuales — deseo, excitación, orgasmo o dolor — son comunes, tienen causas reales y por lo general se pueden tratar.
2. Muchas causas son físicas y se pueden corregir (sequedad, un suelo pélvico tenso, medicamentos); los factores emocionales y de pareja también importan.
3. Vale la pena mencionarlo a su equipo. Informe sobre dolor nuevo, una masa o sangrado después del sexo o después de la menopausia.